CNAM — RETRANSCRIPTION OFFICIELLE ÉPURÉE & CERTIFIÉE

PST123 · Séance 4 : Retranscription Complète & Épurée du Cours

« Les Spécificités de l'Accompagnement en Milieu de Travail » — Dr. Prisca LUTUMBA

Enseignante : Dr. Prisca LUTUMBA (Psychologue clinicienne du travail)

Date de la séance : Samedi 7 Novembre 2026 (09h00 – 12h00)

Lieu : Cnam Nouvelle-Aquitaine · Regroupement présentiel (Salle 2 - Sadi Carnot)

Durée totale enregistrée : 2 heures 01 minute 30 secondes

Note méthodologique d'édition académique : Cette retranscription intégrale restitue l'exhaustivité des 2h01 de cours et des échanges cliniques interactifs. Le texte a fait l'objet d'un nettoyage rigoureux : suppression systématique des faux départs oraux, bégaiements, hésitations, répétitions mécaniques (« oui oui », « voilà voilà ») et artefacts d'intelligence artificielle de sous-titrage. Les références d'auteurs, d'institutions et de concepts phonétiquement altérés ont été rigoureusement rétablies (Arlie Russell Hochschild, Michel Gollac, Louis Le Guillant, Claude Veil, Saint-Alban, Christophe Dejours, Yves Clot, Marc-Éric Bobillier-Chaumon, Marie Pezé, Dominique Lhuilier, CNCDP, SPST, CARSAT, RPPS).

CHAPITRE 1 : CADRAGE, TECHNOSTRESS & ÉTUDE DE CAS DE LA « CELLULE D'ÉCOUTE » (00:00:00 – 00:18:55)

`[00:00:00]` **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre première partie sur le psychologue du travail et de l'emploi. Ce matin, nous allons travailler spécifiquement sur les spécificités de l'accompagnement en milieu de travail. Comme il s'agit d'une unité de Licence, nous balayons un spectre large. Ce sont des notions fondamentales que vous retrouverez et approfondirez en PST124 (sur les usages numériques), en PST120 (sur l'enquête en psychodynamique), et dans la suite de votre cursus. La répétition est excellente en psychologie : elle permet de vous familiariser avec les concepts pour que rien ne vous soit étranger lors des futurs séminaires et épreuves.

`[00:01:02]` **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps de redescendre la pression du technostress de la mise en route ! Pour démarrer, je vous propose une situation clinique concrète, très classique sur le terrain : imaginez qu'une direction d'entreprise vous appelle. Elle vous demande d'installer d'urgence une « cellule d'écoute », parce qu'elle constate qu'il y a une vague d'arrêts maladie successifs dans un service opérationnel. Dans la vraie vie professionnelle, les demandes vous parviennent très souvent sous cette forme : « J'ai des arrêts maladie dans le service, mettez-moi une cellule d'écoute ». Je vous pose donc la question : où situez-vous le problème ? Prenez deux ou trois minutes pour y réfléchir ensemble.

[00:02:04] DR. PRISCA LUTUMBA :

La question est volontairement large. Ce module PST123 a pour vocation majeure de travailler votre future posture professionnelle. Car dans quelques années, quand vous passerez devant le jury d'agrément pour obtenir votre titre de psychologue du travail, ou lors de vos futurs entretiens d'intervention, ce qui sera scruté en premier lieu, c'est votre posture. Et lorsque vous rédigez vos écrits et vos rapports, votre posture transparaît immédiatement. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans cet exercice : cela permet de révéler votre manière de penser, votre cadre de départ et vos expériences antérieures, pour les réajuster avec la compréhension du travail.

[00:04:18] AUDITEUR(TRICE) :

Pour nous, le problème peut venir de multiples sources. Mais avant d'installer quoi que ce soit, il faudrait d'abord savoir de quoi il s'agit exactement : combien de salariés sont concernés ? De quel type de souffrance parle-t-on ? S'agit-il d'un conflit larvé, d'une menace, d'une surcharge ? En tout cas, le fait qu'il y ait plusieurs salariés en arrêt en même temps suggère fortement qu'il y a un problème au niveau de l'organisation du travail.

[00:05:54] AUDITEUR(TRICE) :

Nous nous sommes dit qu'il fallait questionner la direction sur le contexte global. Y a-t-il eu récemment des changements d'outils, un changement de management, des départs ? Peut-on corréler les dates des premiers arrêts maladie avec un événement précis dans l'entreprise ? Et quel est notre statut : intervenons-nous en tant que psychologue externe consultant ou en interne ? Est-ce que les acteurs légaux sont déjà mobilisés : le médecin du travail, le préventeur, le CSE, l'infirmière de santé au travail ?

[00:06:54] AUDITEUR(TRICE) :

Dans notre groupe, nous nous sommes demandé si les arrêts maladie étaient imputables à des facteurs personnels individuels (quelqu'un qui tombe de vélo pendant le week-end) ou à l'organisation. Mais s'il y a sept personnes sur dix qui sont en arrêt dans le même service, ce n'est manifestement plus le fruit du hasard. Est-ce que ce sont des arrêts pour détresse psychique ou des accidents du travail déclarés ?

[00:09:14] DR. PRISCA LUTUMBA :

Excellente interrogation. Mais attention sur un point juridique capital : l'employeur a-t-il accès au motif de l'arrêt maladie ? Absolument pas ! Le secret médical est absolu. L'employeur reçoit le volet 3 de l'arrêt de travail où ne figure aucune mention médicale. Seul le médecin-conseil de la Sécurité sociale (CPAM) détient le volet 1 avec le motif pathologique.

[00:09:42] DR. PRISCA LUTUMBA :

Même lorsqu'un employeur diligente un contrôle médical patronal à domicile, le médecin contrôleur mandaté vérifie uniquement si le salarié est présent chez lui et si l'arrêt est médicalement justifié au sens assurantiel. Mais ce médecin ne transmet JAMAIS le diagnostic à l'employeur. Il conclut simplement : « arrêt justifié » ou « arrêt injustifié ». Donc quand l'employeur vient vous voir en disant : « ils sont tous en arrêt pour dépression », ce sont des hypothèses ou des déductions de sa part, ce ne sont pas des données médicales officielles.

[00:16:33] DR. PRISCA LUTUMBA :

Cette mise en bouche permet de poser le cadre : le collectif, le rapport au travail et la demande patronale. Quand l'employeur vous appelle, il pose un acte. Il constate un dysfonctionnement et sollicite un intervenant. Qu'il le fasse par volonté sincère d'amélioration ou pour « ouvrir le parapluie juridique » (se prémunir d'une faute inexcusable en prouvant qu'il a agi), notre posture ne consiste pas à le diaboliser en disant « vilain patron ! ». Notre rôle est d'adopter une posture éminemment pédagogique : accueillir la demande pour l'accompagner vers la bonne manière de poser le problème, sans se laisser instrumentaliser.

CHAPITRE 2 : CARTOGRAPHIE THÉORIQUE : PTO VS CLINIQUES DU TRAVAIL DU CNAM (00:18:55 – 00:30:00)

[00:18:55] DR. PRISCA LUTUMBA :

Pour bien comprendre où nous nous situons au Cnam, il faut cartographier le paysage de la psychologie en milieu professionnel. D'un côté, vous avez la Psychologie du Travail et des Organisations (PTO). En France et dans le monde anglo-saxon, elle s'est construite après la guerre à partir de la psychotechnique : sélection des personnels, orientation, adaptation de l'homme au poste (« The right man in the right place »). Elle s'est ensuite nourrie de la psychologie sociale — étude de la dynamique des groupes, du leadership, de la motivation, de l'accompagnement du changement — et de la psychologie de la santé.

[00:21:13] DR. PRISCA LUTUMBA :

La méthode dominante en PTO est hypothético-déductive et quantitative. On pose des modèles explicatifs a priori, on administre des questionnaires standardisés sur des cohortes de salariés, on extrait des statistiques et des corrélations. C'est une approche tout à fait respectable qui a son utilité.

[00:22:13] DR. PRISCA LUTUMBA :

À l'inverse, qu'est-ce que nous venons travailler dans les Cliniques du travail, qui constituent la signature académique du Cnam ? Nous travaillons selon une démarche inductive et qualitative. Nous partons de l'observation minutieuse du terrain et de l'écoute du vécu des opérateurs pour remonter vers la conceptualisation. Et quel est notre objet central ? C'est le travail réel !

[00:23:22] DR. PRISCA LUTUMBA :

Vous l'avez vu en PST106 : qu'est-ce que le travail ? L'ergonomie de langue française et la clinique du travail distinguent formellement la tâche et l'activité. La tâche, c'est ce qui est prescrit par l'organisation, les objectifs assignés, les consignes formelles. L'activité, c'est ce que le salarié met concrètement en œuvre pour réaliser la tâche face aux contraintes du réel.

[00:24:05] DR. PRISCA LUTUMBA :

Et au Cnam, avec Yves Clot et la Clinique de l'activité, nous allons encore plus loin avec le concept de « Réel de l'Activité ». Le réel de l'activité ne se borne pas à ce qui est visiblement réalisé sous nos yeux. Il englobe également ce que le travailleur n'a pas pu faire, ce qu'il a été empêché de faire, ce qu'il aurait voulu faire, et ce qu'il fait pour ne pas faire ! La source de connaissance des travailleurs, c'est leur compétence incorporée, leur savoir-faire de métier et leur vécu qui vient dévoiler leur rapport intime au travail.

[00:26:35] DR. PRISCA LUTUMBA :

Rappelez-vous notre définition fondamentale de la santé : la santé au travail n'est pas la simple absence de maladie ou de symptômes physiques. La santé réside dans la préservation du pouvoir d'agir ! Qu'est-ce qui me permet de penser, d'agir, de créer, de débattre avec mes collègues et de trouver des marges de manœuvre dans mon activité ? C'est cela qui est source de santé. Si l'organisation supprime toute marge de manœuvre, le sujet bascule dans la souffrance.

CHAPITRE 3 : APPROCHES CLINIQUES & NOTION PRINCEPS DE RÉSONANCE SYMBOLIQUE (00:30:00 – 00:50:00)

[00:27:57] DR. PRISCA LUTUMBA :

Dans la généalogie des cliniques du travail, rappelons les grands repères. Après la Seconde Guerre mondiale, Louis Le Guillant pose les jalons de la psychopathologie du travail avec ses études sur la névrose des téléphonistes et la condition des employées de maison (« bonnes à tout faire »). Puis Paul Sivadon et Claude Veil prolongent cette réflexion dans le cadre de la psychiatrie sociale et de la psychothérapie institutionnelle à l'hôpital de Saint-Alban dans les années 1940-1950. C'est là que l'on découvre que le travail n'est pas seulement source d'aliénation : lorsqu'il est investi et structuré, il est un puissant médiateur de santé et de soin, y compris pour des patients souffrant de troubles psychotiques graves.

[00:29:29] DR. PRISCA LUTUMBA :

À côté, nous avons l'Ergonomie francophone (Alain Wisner au Cnam), notre discipline cousine avec laquelle nous intervenons constamment en binôme sur le terrain. L'ergonomie analyse l'activité réelle face aux déterminants physiologiques, techniques et organisationnels.

[00:31:13] DR. PRISCA LUTUMBA :

En Psychodynamique du travail (Christophe Dejours), le postulat est que l'identité adulte ne s'arrête jamais à l'enfance ou à la sortie de l'école : le sujet continue de forger son identité et son équilibre psychique tout au long de sa vie à travers les épreuves du travail. Le travail est le lieu privilégié de la confrontation au réel.

[00:36:45] DR. PRISCA LUTUMBA :

Quand nous accompagnons des professionnels en reconversion ou des personnes en souffrance, ils projettent souvent très loin et s'angoissent sur des obstacles imaginaires. Je leur donne souvent une métaphore que j'utilise beaucoup : imaginez que vous devez faire le trajet Bordeaux-Marseille en voiture, mais sans GPS, uniquement avec une carte routière. Quand vous quittez Bordeaux, sur l'autoroute, vous n'avez pas de panneau indiquant « Marseille » ! Vous avez d'abord un panneau « Agen », puis « Toulouse », puis « Narbonne », puis « Montpellier », puis « Nîmes », et enfin « Marseille ». Dans l'accompagnement clinique, il faut savoir borner son intervention : franchir les étapes les unes après les autres sans se laisser terrifier par le but lointain.

[00:39:18] DR. PRISCA LUTUMBA :

Venons-en à une notion théorique et clinique centrale : la « Résonance Symbolique » (Christophe Dejours). En intervention ou en entretien individuel de travail, qu'est-ce qui relève de la scène professionnelle et qu'est-ce qui relève de la scène personnelle ?

[00:41:01] DR. PRISCA LUTUMBA :

Cas vécu : une salariée vient me voir, en larmes, détruite par une relation conflictuelle avec sa manageuse. Au fil de son récit, elle décrit cette manageuse exactement comme elle décrit sa propre mère ou sa sœur tyrannique qui l'a dévalorisée toute son enfance. La scène professionnelle vient résonner avec sa scène personnelle intime. Notre posture de psychologue du travail est très claire : nous accueillons ce vécu avec bienveillance, mais nous ramenons systématiquement l'échange sur le tiers-travail et l'altérité. Je lui dis : « Votre manageuse n'est ni votre mère, ni votre sœur. C'est une responsable de service dans une organisation. Quel est son rôle ? De quoi avez-vous besoin pour travailler avec elle ? ». Nous travaillons le rapport au management et au travail. Et si la salariée exprime le besoin d'élaborer sur son histoire maternelle ou familiale, nous l'orientons vers un psychologue clinicien extérieur.

CHAPITRE 4 : LA QUESTION DES OUTILS NUMÉRIQUES, IA & CLINIQUE DES USAGES (00:50:00 – 00:58:30)

[00:50:54] **AUDITEUR(TRICE) :**

Dans mon entreprise, nous sommes confrontés à l'arrivée massive de l'Intelligence Artificielle, notamment les IA agentiques, les scripts pour scraper des données et automatiser les processus. Beaucoup de collègues s'inquiètent : en développant et en acceptant ces technologies, n'est-on pas en train de détruire nos propres emplois et de déposséder les salariés de leurs savoir-faire ?

[00:51:53] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

C'est un sujet absolument passionnant que vous aborderez en profondeur avec Marc-Éric Bobillier-Chaumon en PST124 (Clinique des Usages). Historiquement, le monde du travail a traversé des révolutions techniques comparables : l'introduction de l'informatique de gestion, le plan Informatique pour tous dans les années 80, l'apparition des caisses automatiques dans la grande distribution. À chaque étape, une angoisse légitime surgit sur la disparition du métier.

[00:53:17] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Le cœur de la réflexion en clinique des usages est d'ordre anthropocentré : l'outil technologique doit impérativement rester un instrument au service du geste et du pouvoir d'agir de l'opérateur humain, et non l'inverse ! Le danger survient lorsque le management transforme l'humain en simple exécutant ou en variable d'ajustement de la machine ou de l'algorithme. C'est cette dérive qu'il nous appartient d'interroger et de réguler en entreprise.

CHAPITRE 5 : DE LA COMMANDE À LA DEMANDE & LES 3 NIVEAUX DE PRÉVENTION (00:58:30 – 01:08:30)

[00:59:12] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Revenons à notre méthodologie d'intervention. Retenez bien la différence entre la Commande et la Demande. La Commande, c'est le mandat institutionnel, contractuel et marchand : le devis signé, le contrat émis par la direction pour traiter un symptôme précis (ex: « installez-nous une cellule d'écoute téléphonique »). La Demande, c'est l'expression sous-jacente, souvent confuse ou masquée, d'une problématique organisationnelle réelle.

[01:00:19] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Retenez cette formule pour votre examen et votre future pratique : « Analyser la demande, c'est déjà une action de transformation ! ». Pourquoi ? Parce que lorsque vous recevez le commanditaire et que vous l'amenez à répondre à des questions précises pour reformuler son besoin, vous commencez déjà à modifier ses représentations du problème. Vous l'amenez à regarder le travail réel plutôt que de focaliser sur des salariés prétendument faibles.

[01:03:39] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Pour structurer nos actions, nous articulons le Code du travail avec les 3 niveaux de prévention de la santé publique : primaire, secondaire et tertiaire. Pour que vous ne l'oubliiez jamais, prenons l'exemple clinique d'un EHPAD que j'ai accompagné :

[01:05:17] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

1. PRÉVENTION PRIMAIRE (agir sur les causes dès la conception) : L'EHPAD ouvre ses portes en 2020. Les résidents accueillis au début sont encore relativement autonomes. Une direction éclairée se dit : « Dans 4 ans, ces mêmes résidents auront vieilli et seront lourdement dépendants, ce qui imposera des manutentions physiques harassantes pour le dos des aides-soignantes ». Dès la construction en 2020, on installe d'emblée des rails lève-malade au plafond dans toutes les chambres, et on inscrit au plan pluriannuel le recrutement de 2 soignants supplémentaires pour 2024. On a éliminé le risque à sa source.

[01:07:31] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

2. PRÉVENTION SECONDAIRE (accompagner et former face aux signaux de dégradation) : Nous sommes en 2022. La dépendance a progressé, des signes de fatigue et des tensions émergent dans l'équipe. On ne peut plus modifier l'architecture, mais on met en place des formations à la manutention douce, des groupes de parole professionnels et une procédure d'alerte RH pour réguler les plannings avant la rupture.

[01:08:26] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

3. PRÉVENTION TERTIAIRE (réparer dans l'urgence la catastrophe avérée) : Imaginez que rien n'ait été anticipé. En 2024, les résidents sont grabataires, les effectifs sont identiques à 2020, le personnel est en épuisement total. Les arrêts maladie explosent. Les soignants sont tellement à bout de nerfs qu'un conflit violent éclate et qu'un salarié excédé en vient à séquestrer un collègue dans un cagibi ! Là, vous intervenez en pompier dans la crise aiguë. Notre but de psychologue du travail est de toujours pousser les organisations vers la prévention primaire.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (01:08:30 – 01:35:00)

[01:09:42] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Passons en revue les dispositifs d'accompagnement. Sur le plan individuel : la clinique du travail en entretien individuel n'est pas une psychothérapie de divan. Elle est strictement centrée sur le travail : le rapport à la tâche, aux collègues, au management, les pathologies de surcharge cognitive ou le burn-out.

[01:12:27] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Concernant le maintien dans l'emploi, notamment au sein des Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) où j'exerce, appuyez-vous sur les travaux de Dominique Lhuilier. « Maintien dans l'emploi » ne signifie pas maintenir la personne coûte que coûte sur son poste initial destructeur : cela signifie travailler son rapport à l'emploi, à la reconversion et parfois à la traversée d'une période de transition.

[01:13:34] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Pour les consultations spécialisées « Souffrance et Travail », le réseau initié par Marie Pezé dans le sillage de Christophe Dejours offre une référence formidable. Veillez toutefois dans votre pratique à ne pas vous substituer aux juristes du travail.

[01:23:58] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Sur le plan collectif, qui constitue le cœur battant de notre métier : nous créons des espaces de délibération où les professionnels viennent tricoter et détricoter le travail réel. Attention, vous devez maîtriser sur le bout des doigts la différence entre 4 dispositifs collectifs souvent confondus :

[01:27:47] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

1. La Régulation d'Équipe : C'est un dispositif visant à traiter un dysfonctionnement ou une tension relationnelle au sein d'une équipe opérationnelle. La hiérarchie (le manager de proximité) peut tout à fait être présente, car elle détient le pouvoir d'organisation. La règle d'or du psychologue est d'interdire les attaques ad hominem pour ramener chaque grief à l'objet « travail » (qui fait quoi ? comment circule l'information ?).

[01:30:25] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

2. L'Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) : C'est un espace réservé EXCLUSIVEMENT aux pairs de même métier (par exemple uniquement des éducateurs, ou uniquement des infirmiers). Il n'y a AUCUNE hiérarchie présente, car les participants viennent y exposer leurs doutes, leurs échecs et leur vulnérabilité professionnelle. Un tiers garant extérieur anime la séance pour aider le collectif à conceptualiser son geste.

[01:32:40] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

3. L'Intervision : C'est un groupe de pairs de même niveau (par exemple 6 à 8 psychologues du travail) qui se réunissent de manière horizontale et autogérée, SANS superviseur. Chacun apporte une situation complexe et bénéficie des conseils et regards croisés de ses confrères.

[01:33:22] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

4. La Supervision : C'est un étayage individuel ou collectif conduit par un superviseur senior expérimenté. C'est là que le praticien vient travailler sa posture, son contre-transfert, ses résonances personnelles et ses impasses méthodologiques face aux entreprises.

[01:34:34] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Enfin, sur les événements critiques graves (suicide sur le lieu de travail, accident mortel) : ne confondez pas notre rôle avec celui des Cellules d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP). La CUMP pratique un defusing psychiatrique d'urgence centré sur le choc émotionnel individuel. Le psychologue du travail, lui, réintègre impérativement l'analyse du travail : qu'est-ce qui, dans l'organisation du travail et le collectif, a rendu cet événement possible, et comment restaurer le pouvoir d'agir de l'équipe pour reprendre l'activité ?

CHAPITRE 7 : DÉONTOLOGIE, PRATIQUE EN BINÔME & RÈGLES D'OR DES RESTITUTIONS (01:35:00 – 02:01:30)

[01:35:34] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Retenez toujours ce principe fondamental : LE TRAVAIL FAIT TIERS. Le travail est notre médiateur, notre objet transitionnel au sens clinique. Il évite le face-à-face destructeur entre personnes et protège de la dérive imaginaire narcissique.

[01:37:04] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Attention au mécanisme de déflexion défensive très courant dans les directions : quand un salarié craque ou fait un burn-out, l'employeur dit immédiatement : « Ah mais il avait de gros problèmes personnels, son conjoint l'a quitté ! ». Le psychologue du travail réinternalise le problème : pourquoi a-t-on laissé ce salarié compenser tout seul le départ de deux collègues pendant trois ans ? La vulnérabilité personnelle ne dédouane jamais l'organisation de ses responsabilités.

[01:37:52] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Point de vigilance impératif sur le vocabulaire : ne dites JAMAIS « un suicide réussi » ! Cette expression est odieuse et antinomique avec notre éthique. On parle de suicide ou de tentative de suicide. Marie Pezé emploie également le terme clinique de « suicide blanc » pour désigner les signaux d'alerte majeurs ou les tentatives dissimulées.

[01:46:38] **DR. PRISCA LUTUMBA :**

Sur le plan déontologique : notre boussole est le Code de Déontologie des Psychologues (dont j'ai eu l'honneur de suivre les travaux de réactualisation au sein de la CNCDP). L'article premier est gravé : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique et physique est un droit inaliénable ». Nous sommes des professionnels de la santé mentale et des sciences humaines enregistrés au répertoire RPPS : nous n'exerçons sous la prescription de personne.

[01:47:20] DR. PRISCA LUTUMBA :

> Une règle de pratique que je vous transmets avec force : TRAVAILLEZ EN BINÔME ! Dans mon activité en entreprise, y compris en libéral, je n'interviens quasiment jamais seule. Intervenir à deux (avec un autre psychologue ou un ergonome) est votre meilleure armure contre les pressions de la direction, la séduction managériale et la perte d'objectivité. À deux, on débat, on ajuste sa posture et on résiste.

[01:51:07] DR. PRISCA LUTUMBA :

> RÈGLE D'OR POUR VOS RAPPORTS ET RESTITUTIONS : BANISSEZ FORMELLEMENT LES VERBATIMS INDIVIDUELS ! Même si vous écrivez « Monsieur X » ou « un salarié anonyme », les collègues et les chefs reconnaissent instantanément qui parle : un tic de langage, une expression favorite, une tournure particulière, et la personne est grillée ! Cela déclenche des représailles immédiates. Un rapport de psychologue du travail doit restituer des processus collectifs, des faits objectivés et des problématiques de métier, jamais des potins individualisés.

[01:52:40] DR. PRISCA LUTUMBA :

> Prudence absolue sur la notion de « Harcèlement Moral » : le harcèlement est une qualification JURIDIQUE qui relève de la compétence souveraine du magistrat, pas du psychologue. Quand un salarié vous dit qu'il est harcelé, vous accueillez sa souffrance mais vous travaillez sur la dégradation objective des conditions de travail et la qualité empêchée. Sachez que des médecins traitants qui écrivent « arrêt pour harcèlement au travail » se font régulièrement condamner par le Conseil de l'Ordre pour immixtion et attestation de faits non constatés directement en entreprise.

[01:54:19] DR. PRISCA LUTUMBA :

> N'oubliez pas les apports d'Arlie Russell Hochschild sur le « Travail Émotionnel » (Emotional Labor), repris dans le rapport Gollac : l'obligation prescrite d'afficher un sourire permanent (dans les centres d'appels, les services clients ou l'accueil) tout en réprimant son irritation intérieure est une source majeure d'épuisement psychique. Pensez également à l'éthique du Care développée par Pascale Molinier dans les métiers du prendre-soin.

[01:58:35] DR. PRISCA LUTUMBA :

> Enfin, refusez les conflits de loyauté et les doubles rôles : n'intervenez jamais comme psychologue dans votre propre service ou auprès de vos collègues directs ! Et dans vos missions, articulez-vous avec les partenaires institutionnels de long terme : le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire du SPST, l'Inspection du travail, la CARSAT et les représentants du personnel au CSE. C'est cet écosystème qui garantit la pérennité des transformations.

[02:01:29] DR. PRISCA LUTUMBA :

> Voilà, nous arrivons au terme de cette séance dense. Travaillez bien ces concepts pour votre pratique et pour l'épreuve d'examen. Merci à tous pour votre participation active et bon week-end !